

Capítulo 14: Guía de Estudio de Alto Rendimiento NBDHE

Periodoncia y Periodontología Clínica (Español)

Periodoncia y Periodontología Clínica

1. Anatomía Periodontal y Espacio Biológico

- **Encía Adherida:**
 - Ancho: Más ancha en la zona **Anterior Superior** (3.5–4.5 mm); más estrecha en la zona ****Premolar Inferior Vestibular**** (1.8 mm).
 - Límite: Separada de la mucosa alveolar por la **Línea o Unión Mucogingival (UMG)** (ausente en el paladar).
- **Epitelio de Unión (EU):**
 - Longitud: **0.25 a 1.35 mm** (promedio $\approx$ 0.97 mm).
 - Unión: Se une al diente mediante **hemidesmosomas** y lámina basal interna. Muy permeable al fluido crevicular (GCF) y neutrófilos.
- **Cresta Ósea Alveolar:**
 - Posición normal: **1.5 a 2.0 mm apical** a la unión cemento-esmalte (UCE) en salud.
- **Defectos Óseos:**
 - **Fenestración:** "Ventana" aislada de pérdida ósea donde la raíz queda expuesta pero el hueso marginal permanece intacto.
 - **Dehiscencia:** Hendidura o defecto óseo continuo que incluye la pérdida del margen óseo crestral.

2. Etiología y Patogenia Periodontal

- **Microbiología y Biopelícula:**
 - Primeras células de defensa en gingivitis inicial (Estadio I): **Neutrófilos (PMNs)**.
 - Biopelícula apical subgingival: Predominio de **bacilos y espiroquetas Gram-negativas anaerobias** (Complejo Rojo: *P. gingivalis*, *T. forsythia*, *T. denticola*).
 - Cálculo: Factor **retenedor de placa**, no el iniciador químico primario.
- **Agrandamiento Gingival Farmacológico:**
 - Bloqueadores de canales de calcio (p. ej., **Nifedipino**, Amlodipino).
 - Inmunosupresores (p. ej., **Ciclosporina**).
 - Anticonvulsivantes (p. ej., **Fenitoína / Epamin**).
 - Afecta principalmente el sector **anterior vestibular**.
- **Enfermedades Periodontales Necrosantes (EPN):**
 - Papilas interdentes decapitadas en forma de cráter, dolor agudo, sangrado espontáneo, pseudomembrana y olor fétido.

3. Terapia Periodontal No Quirúrgica (TPNQ) y Reevaluación

- **Objetivo de TPNQ:** Eliminar cálculo y biopelícula, disminuir inflamación y favorecer la cicatrización biológica.
- **Respuesta Óptima:** Bolsas iniciales de ****4 a 6 mm**** presentan la mayor reducción de profundidad al sondaje y ganancia de inserción clínica.

- **Tiempo de Reevaluación:** **4 a 6 semanas** post-tratamiento para permitir la cicatrización del epitelio de unión largo y maduración del colágeno.
- **Sangrado al Sondaje (BOP):** Mejor indicador clínico de actividad y respuesta al tratamiento.

4. Cirugía Periodontal e Implantes Dentales

- **Regeneración Tisular Guiada (RTG):** Uso de membranas barrera para evitar la migración apical del epitelio, permitiendo la repoblación del ligamento periodontal y hueso.
- **Retiro de Suturas:** Sujetar el nudo con pinzas algodonerías, levantarlo y cortar pegado al tejido por debajo del nudo.
- **Biología y Mantenimiento de Implantes:**
- **Sellado Perimucoso:** Adaptación epitelial alrededor del pilar de titanio.
- Pérdida ósea fisiológica en el 1.er año: **1 a 2 mm**.
- Tasa de éxito a 5 años: $\geq 85\%$.
- Instrumental: Curetas de titanio, plástico o grafito para evitar rayar la superficie de óxido de titanio.
- **Fluoruro con Acción Antimicrobiana:** **Fluoruro Estannoso (SnF_2)**.